Клинические рекомендации

Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия нёбных миндалин

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J31.1** — Хронический назофарингит **J35.1** — Гипертрофия миндалин **J35.2** — Гипертрофия аденоидов **J35.3** — Гипертрофия миндалин с гипертрофией аденоидов **J35.8** — Другие хронические болезни миндалин и аденоидов
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 25.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/662_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

2.5 Жалобы и анамнез 5

3. Диагностика 5

3.1 Физикальное обследование 5

3.2 Инструментальные исследования 5

3.3 Иные исследования 6

3.4 Консультации специалистов 6

4. Лечение 6

4.1 Хирургическое лечение 7

4.2 Консервативное лечение аденоидита 7

4.3 Послеоперационное обезболивание 8

4.4 Послеоперационное ведение 9

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 9

5.1 Профилактика 9

5.2 Показания к госпитализации и выписке 10

5.3 Факторы, влияющие на исход лечения 10

6. Источник и актуальность **10**

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 10

1. Основные положения

- Наличие у ребёнка глоточной и нёбных миндалин само по себе не является патологией. Показанием к обследованию служат жалобы, клинические проявления или сопутствующее заболевание, на течение которого могут влиять аденоиды и нёбные миндалины.
- Гипертрофия нёбных миндалин диагностируется на основании жалоб, анамнеза и данных фарингоскопии с обязательной оценкой нижнего полюса миндалин; диагноз гипертрофии аденоидов требует инструментального подтверждения (эндоскопия носоглотки, рентгенография носоглотки или компьютерная томография).
- Пальцевое исследование носоглотки для диагностики аденоидов у детей не проводится.
- При наличии показаний аденоиды и нёбные миндалины оперируют в плановом порядке; при отсутствии показаний или наличии абсолютных противопоказаний необходимо динамическое наблюдение оториноларинголога.
- Консервативное лечение детям с гипертрофией аденоидов назначают только при признаках аденоидита. У детей младше 7–9 лет при отсутствии осложнений и значимого влияния на качество жизни аденоидит не рассматривается как патология, и тактика ограничивается наблюдением.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Гипертрофия аденоидов характеризуется увеличением глоточной миндалины со стойким затруднением носового дыхания и (или) другими осложнениями: обструктивными нарушениями сна, экссудативным средним отитом, деформацией лицевого скелета. Гипертрофия нёбных миндалин представляет собой увеличение одной или обеих нёбных миндалин; она может протекать бессимптомно или проявляться храпом, остановками дыхания во сне, нарушениями глотания и артикуляции, деформацией лицевого скелета.

Аденоидит представляет собой реактивные воспалительные изменения глоточной миндалины как органа местного иммунитета слизистых оболочек в ответ на антигены, попадающие на слизистую оболочку носа и глотки. У детей младше 7–9 лет при отсутствии значимого влияния на качество жизни и осложнений (например, средних отитов) аденоидит не рассматривается как патология.

Острый синусит считается рецидивирующим при 4 и более эпизодах за последний год. Острый средний отит считается рецидивирующим при 3 и более эпизодах за 6 месяцев или 4 и более эпизодах за 12 месяцев.

2.2 Этиология

Наиболее вероятными причинами считаются вирусная инфекция, генетическая предрасположенность и влияние факторов окружающей среды. Роль бактериальной инфекции, гастроэзофагеального рефлюкса и аллергии остаётся дискутабельной. Как правило, действует одновременно несколько факторов, и выделить ведущий не удаётся.

Особое внимание уделяется вирусу герпеса IV типа: герпетическая инфекция является одной из частых причин выраженной гипертрофии глоточной миндалины со стойкой обструкцией носоглотки.

2.3 Классификация

Для оценки степени гипертрофии аденоидов в России наиболее широко применяется классификация А. Г. Лихачёва, основанная на том, какую часть сошника прикрывает ткань глоточной миндалины. При I степени ткань миндалины прикрывает не более верхней трети сошника, при II степени от 1/3 до 2/3, при III степени более 2/3.

Для нёбных миндалин наиболее широко применяется классификация Б. С. Преображенского. Расстояние между вертикалью, проведённой через середину язычка, и линией по краю передней (нёбно-язычной) дужки делится на три части. При I степени миндалина занимает треть этого расстояния, при II степени две трети, при III степени миндалины достигают язычка и соприкасаются друг с другом.

2.4 Клиническая картина

Жалобы и симптомы чаще всего отмечаются при гипертрофии III степени. При I и II степени пациенты, как правило, хотя и не всегда, жалоб не предъявляют.

При гипертрофии нёбных миндалин родители, как правило, предъявляют жалобы только на храп. В отличие от храпа при воспалении, он носит постоянный характер и часто не зависит от положения тела во сне. В ряде случаев родители отмечают и классические признаки синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС): дневную сонливость и снижение успеваемости. Значительно реже наблюдаются изменения прикуса и лёгкая дисфония.

При гипертрофии аденоидов, в том числе в сочетании с увеличением нёбных миндалин, жалобы более разнообразны. Помимо нарушений дыхания во сне, беспокоят стойкое затруднение носового дыхания и его последствия: постоянно открытый рот, гипоназальность (закрытая гнусавость), сухость во рту. Нередко отмечается снижение слуха вследствие экссудативного среднего отита или указание на повторные острые средние отиты в анамнезе. Даже при II степени ринологические симптомы (заложенность носа, стекание отделяемого по задней стенке глотки, кашель) после перенесённого простудного заболевания могут сохраняться до нескольких недель. У школьников с аденоидами часто встречаются острые синуситы, в том числе рецидивирующие.

Основной жалобой при аденоидите является кашель, как правило продуктивный, ночной и утренний; он является проявлением постназального синдрома, то есть стекания отделяемого по задней стенке глотки. Аденоидит может развиваться и при небольших размерах глоточной миндалины. При аденоидите на фоне гипертрофии аденоидов II–III степени пациенты, как правило, одновременно предъявляют жалобы на заложенность носа и кашель.

Реактивные изменения глоточной миндалины после перенесённого простудного заболевания или на фоне аллергического ринита у детей младше 7–9 лет носят физиологический характер. Патологией они не считаются при отсутствии осложнений (средних отитов, острого синусита) и если симптомы (кашель или затруднение носового дыхания) не нарушают сон и дневную активность ребёнка.

Симптомы гипертрофии аденоидов и аденоидита не являются патогномоничными. Гипертрофию аденоидов и нёбных миндалин дифференцируют с острым и хроническим риносинуситом, аллергическим, вазомоторным и гипертрофическим ринитом, искривлением перегородки носа, инородными телами и новообразованиями полости носа и носоглотки. Гипертрофия аденоидов часто сопутствует острому и хроническому синуситу и аллергическому риниту.

Клиническая картина у взрослых не отличается от таковой у детей.

2.5 Жалобы и анамнез

Необходимо уточнить длительность заболевания, с чем пациент связывает его начало, динамику жалоб и их влияние на сон и повседневную активность ребёнка, проводившееся лечение, его эффективность и нежелательные явления. Важно выяснить, сохраняются ли симптомы вне эпизодов острых респираторных инфекций и насколько они выражены в настоящее время по сравнению с прошлым. Из анамнеза жизни выясняются сопутствующие заболевания, прежде всего аллергические: наблюдается ли по ним ребёнок у специалиста, какое лечение получает, планируются ли операции. Большое значение имеют перенесённые операции и манипуляции в полости носа, включая назотрахеальную интубацию и установку любых назальных зондов.

3. Диагностика

Наличие у ребёнка глоточной и нёбных миндалин не является патологией. Обследование оправдано при наличии жалоб, клинических проявлений или сопутствующего заболевания, на течение которого могут влиять аденоидит, гипертрофия аденоидов или нёбных миндалин.

Гипертрофия нёбных миндалин диагностируется на основании жалоб, анамнеза и физикального обследования, включающего фарингоскопию с обязательной оценкой нижнего полюса миндалин. Для диагноза гипертрофии аденоидов, кроме того, необходимо инструментальное исследование: эндоскопия носоглотки, рентгенография носоглотки или компьютерная томография (КТ).

3.1 Физикальное обследование

Каждого пациента осматривает оториноларинголог для оценки общего состояния, выраженности симптомов и сопутствующей патологии как в амбулаторных условиях, так и при госпитализации в ЛОР-отделение.

Пальцевое исследование носоглотки для диагностики аденоидов у детей в амбулаторной практике не проводится: его результаты крайне субъективны, процедура неприятна для ребёнка и может приводить к травме структур глотки.

Лабораторные исследования для диагностики гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин не применяют; их используют лишь для диагностики сопутствующих заболеваний.

3.2 Инструментальные исследования

При симптомах, характерных для гипертрофии аденоидов, выполняют эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки.

Наиболее предпочтительна эндоскопия гибким эндоскопом с возможностью сохранения изображения в виде фото или видео. Эндоскопия носоглотки является методом первого выбора для дифференциальной диагностики и для оценки состояния носоглотки после операции, в том числе в отдалённые сроки. Осмотр ригидным эндоскопом дети, особенно дошкольного возраста, переносят хуже, а осмотр без сохранения изображения значительно менее объективен при последующих консультациях.

Рентгенографию носоглотки в боковой проекции применяют при симптомах, характерных для гипертрофии аденоидов, для оценки размеров глоточной миндалины.

Метод является недорогим, доступным и безболезненным. К недостаткам относятся небольшая лучевая нагрузка, необходимость правильной укладки с открытым ртом и невозможность дифференцировать аденоиды от других объёмных образований носоглотки; результат не всегда соответствует выраженности симптомов. После аденотомии рентгенография малоинформативна, поскольку не позволяет отличить аденоиды от компенсаторной гипертрофии трубных валиков и оценить рубцовые изменения.

КТ верхних дыхательных путей и шеи проводят не всем пациентам, а по специальным показаниям: в сложных случаях, когда необходимо дифференцировать гипертрофию аденоидов от другой патологии носа со сходными симптомами или диагностировать их одновременно.

При гипертрофии аденоидов состояние среднего уха объективно оценивают с помощью тимпанометрии.

3.3 Иные исследования

Исследование мазков из глотки на микрофлору для диагностики гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин у детей не показано. Условно-патогенные бактерии часто выявляются в глотке и у здоровых лиц, поэтому при отсутствии признаков бактериальной инфекции ни наличие, ни отсутствие роста не позволяют оценить риск и прогноз.

3.4 Консультации специалистов

По специальным показаниям пациент направляется к аллергологу-иммунологу для подтверждения или исключения сопутствующей аллергической патологии и согласования лечения. Плановая консультация необходима при клинических и анамнестических признаках аллергического ринита, атопической бронхиальной астмы или атопического дерматита.

Консультация показана в первую очередь при глазных симптомах или повторяющемся чихании и зуде в носу; при ринологических симптомах, которые пациент связывает с цветением растений, животными или другими определёнными ситуациями; при повторных приступах кашля, свистящего или затруднённого дыхания и стеснения в груди, особенно ночью и рано утром; при кожных проявлениях атопического дерматита, крапивницы и других аллергических заболеваний кожи; при рецидивирующих острых средних отитах или риносинуситах.

При признаках повторяющихся обструктивных нарушений сна пациент по возможности направляется в плановом порядке к специалисту по расстройствам сна для объективной диагностики и согласования лечения.

При врождённых или приобретённых изменениях челюстно-лицевой области показана плановая консультация ортодонта.

По специальным показаниям пациент направляется к инфекционисту для диагностики персистирующих вирусных инфекций, прежде всего герпесвирусной.

Показанием является наличие хотя бы одного из следующих признаков, сохраняющегося 3 месяца и более: увеличение лимфатических узлов в 3 группах и более (не менее 3 узлов в каждой); увеличение печени и (или) селезёнки; снижение абсолютного числа нейтрофилов в анализе крови ниже возрастной нормы и (или) общего числа нейтрофилов ниже 5×10^9/л. Оториноларинголог только оценивает симптомы, решение о лабораторном поиске вирусов принимает инфекционист.

4. Лечение

При наличии показаний гипертрофию аденоидов и нёбных миндалин устраняют хирургически в плановом порядке. При отсутствии показаний или наличии абсолютных противопоказаний показано динамическое наблюдение оториноларинголога. При хронической или врождённой сопутствующей патологии оперируют только по согласованию с профильным специалистом.

Абсолютными противопоказаниями к операции являются шок, острая стадия инфаркта миокарда и нарушения мозгового кровообращения, поздние стадии тяжёлых инфекционных и онкологических заболеваний, тяжёлое, крайне тяжёлое или терминальное состояние, обусловленное сопутствующими заболеваниями. К относительным противопоказаниям относятся неконтролируемое или плохо контролируемое течение сопутствующей соматической патологии и аномалии строения носа, резко повышающие риск серьёзных интраоперационных осложнений.

Консервативное лечение оправдано только при клинических и анамнестических признаках воспаления глоточной миндалины (аденоидита) или нёбных миндалин (тонзиллита) при наличии соответствующих жалоб или осложнений.

4.1 Хирургическое лечение

Аденотомия при гипертрофии аденоидов выполняется по специальным показаниям для восстановления проходимости носоглотки и только при отсутствии противопоказаний.

Показаниями у детей являются: частые или регулярные эпизоды обструктивных нарушений сна (храп, в ряде случаев с дневной сонливостью и вялостью); экссудативный средний отит, сохраняющийся 3 месяца, резистентный к консервативному лечению и подтверждённый тимпанометрией; рецидивирующие острые средние отиты или острые синуситы (3 эпизода и более за 6 месяцев или 4 и более за 12 месяцев) после исключения других причин, прежде всего иммунодефицита, и при неэффективности медикаментозной профилактики; хронический синусит с выраженными симптомами или частыми обострениями при неэффективности 1–2 курсов консервативного лечения; стойкое затруднение носового дыхания при отсутствии других причин, ухудшающее качество жизни или приводящее к деформации лицевого скелета по данным цефалометрии и заключению ортодонта или челюстно-лицевого хирурга; заключение других специалистов о необходимости аденотомии как этапа лечения сопутствующего заболевания, например перед кардиохирургическим вмешательством.
При возможности объективной оценки обструктивных нарушений сна ориентиром служит индекс апноэ-гипопноэ: значения от 5 до 15 соответствуют среднетяжёлой форме, более 15 тяжёлой форме.
Детям аденотомию предпочтительно выполнять под общим обезболиванием в ЛОР-отделении стационара или в стационаре кратковременного пребывания.

Тонзиллотомию детям с гипертрофией нёбных миндалин выполняют по специальным показаниям для уменьшения размеров миндалин. Основным показанием являются частые или регулярные эпизоды обструктивных нарушений сна (храп, в ряде случаев с дневной сонливостью и вялостью); при возможности ориентиром служит индекс апноэ-гипопноэ, как и при аденотомии.

При одновременном наличии у ребёнка показаний и к тонзиллотомии, и к тонзиллэктомии предпочтение отдаётся тонзиллэктомии. Тонзиллотомию предпочтительно проводить под общим обезболиванием в ЛОР-отделении стационара или в стационаре кратковременного пребывания.

При сочетанной гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин аденотомию сочетают с тонзиллотомией по тем же показаниям, что и аденотомия.

Такое вмешательство проводится только под общим обезболиванием с обязательным визуальным контролем операционного поля; в раннем послеоперационном периоде пациент находится под наблюдением в ЛОР-отделении стационара.

Взрослым с гипертрофией нёбных миндалин и синдромом обструктивного апноэ сна при отсутствии противопоказаний показана тонзиллэктомия для уменьшения симптомов апноэ.

> Для рекомендации о тонзиллэктомии у взрослых не указаны ни уровень убедительности рекомендаций, ни уровень достоверности доказательств. Кроме того, в разделах о госпитализации, послеоперационном обезболивании и реабилитации речь идёт только об аденотомии и тонзиллотомии, тонзиллэктомия у взрослых не упоминается.

4.2 Консервативное лечение аденоидита

Консервативное лечение детей с гипертрофией аденоидов оправдано только при признаках аденоидита: продуктивном кашле вследствие постназального затёка, выделениях из носа, периодическом затруднении носового дыхания. У детей младше 7–9 лет при отсутствии значимого влияния на сон, приём пищи и повседневную активность и при отсутствии осложнений (например, средних отитов) такое состояние не рассматривается как патология, и тактика ограничивается наблюдением.

Всем пациентам с аденоидитом рекомендована ирригационно-элиминационная терапия (промывание полости носа).

Орошение полости носа проводится 1–2 раза в день изотоническими или гипертоническими (1,5–3%) солевыми растворами на основе морской воды; это облегчает туалет полости носа, уменьшает выраженность симптомов и улучшает условия для последующего применения местных лекарственных средств. Детям дошкольного возраста промывание полости носа большими объёмами раствора не рекомендуется из-за высокого риска средних отитов.

По специальным показаниям при аденоидите применяют местные антибактериальные препараты для подавления условно-патогенной микрофлоры носоглотки.

Применяются назальный спрей фрамицетина, у детей старше 2,5 года комбинированный препарат дексаметазон + неомицин + полимиксин B + фенилэфрин или раствор для ингаляций тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат. Курс короткий, до 7 дней. Показанием служат признаки бактериальной инфекции: слизисто-гнойные выделения из носа и по задней стенке глотки в течение всего дня или отсутствие улучшения в течение 7–10 дней противовоспалительной терапии.
Введение в полость носа растворов антибиотиков, предназначенных для парентерального, внутриконъюнктивального или ушного применения, не рекомендуется: они не предназначены для полости носа и могут нарушать мукоцилиарный транспорт.

Пациентам старше 2 лет с аденоидитом рекомендованы отхаркивающие муколитические препараты для уменьшения постназального затёка. Применяются только препараты с преимущественно мукорегулирующим действием; оптимальным в рекомендации назван карбоцистеин.

Карбоцистеин в форме сиропа, в том числе в виде карбоцистеина лизина моногидрата, назначается курсом от 1 до 3 месяцев. Препарат уменьшает постназальный затёк и повышает вероятность разрешения сопутствующего экссудативного среднего отита. При монотерапии отличие от выжидательной тактики становится заметным лишь к 2–3-й неделе. Одновременное назначение других муколитиков, в том числе местных, не рекомендуется во избежание усиления затёка.

Детям старше 2 лет с аденоидитом и сопутствующим аллергическим ринитом применяют топические глюкокортикостероиды: #мометазон в виде назального спрея по 1 дозе (50 мкг) в каждый носовой ход 1 раз в сутки (100 мкг в сутки) курсом от 1 до 3 месяцев.

Ни гипертрофия аденоидов, ни аденоидит, ни назофарингит не зарегистрированы в России в качестве показания ни для одного топического глюкокортикостероида; знак # обозначает применение вне инструкции по медицинскому применению.

Масла, в первую очередь масло туи, при гипертрофии аденоидов и аденоидите не применяются: их эффективность не доказана, а в полости носа они угнетают функцию ресничек мерцательного эпителия, нарушают эвакуацию секрета и повышают риск бактериальной инфекции.

Ежедневное промывание полости носа растворами антисептиков не рекомендуется: эффективность не доказана, нарушается мукоцилиарный транспорт, возможны местные дисбиотические изменения.

4.3 Послеоперационное обезболивание

При болевом синдроме после аденотомии и (или) тонзиллотомии применяют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или парацетамол. Обезболивание необходимо при жалобах на боль или других её проявлениях: отказе от еды и питья, повторной рвоте и тошноте.

Препарат	Доза у детей
Ибупрофен	8–10 мг/кг на приём, не более 30 мг/кг в сутки, внутрь в лекарственной форме, соответствующей возрасту (таблетки, покрытые оболочкой, — с 6 лет); детям младшего возраста — ректальные суппозитории.
Кетопрофен	С 6 лет — гранулы для приготовления раствора для приёма внутрь (кетопрофена лизиновая соль), 40 мг на приём до 3 раз в день.

Препарат	Доза у детей
Парацетамол	10–15 мг/кг на приём, не более 60 мг/кг в сутки, в любой лекарственной форме, соответствующей возрасту. При невозможности приёма внутрь и отсутствии суппозиториев — парентерально 15 мг/кг на введение.

4.4 Послеоперационное ведение

После аденотомии и (или) тонзиллотомии показан осмотр оториноларинголога перед выпиской и амбулаторно через 7–14 дней после выписки для оценки состояния и исключения поздних послеоперационных осложнений.

В течение 5–7 дней после операции необходимо соблюдение охранительного режима.

Охранительный режим включает ограничение контактов (исключение посещения детского коллектива и людных мест), ограничение физической нагрузки и исключение перегревания, особенно области головы и шеи, в том числе отказ от горячей пищи и питья.

При сохранении дисфонии более месяца после операции пациент направляется к логопеду-дефектологу.

При сохранении симптомов обструктивных нарушений сна более 6–8 недель после операции пациент направляется к специалисту по расстройствам сна.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Специфическая профилактика гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин отсутствует. Поскольку важную роль играют респираторные вирусы, следует соблюдать общие правила профилактики острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Ряд лекарственных препаратов может применяться для плановой и экстренной профилактики аденоидита у детей.

Детям старше 1 года из групп риска по респираторным инфекциям рекомендованы стандартизированные растительные препараты для приёма внутрь из группы прочих антисептиков для профилактики эпизодов ОРВИ, а также для сокращения длительности и уменьшения тяжести последующих эпизодов аденоидита.

К ним относятся препараты, содержащие корень алтея, цветки ромашки, хвощ, листья грецкого ореха, тысячелистник, кору дуба и одуванчик лекарственный. Они назначаются также для лечения аденоидита при появлении симптомов ОРВИ в качестве монотерапии или в комплексе.

Детям старше 3 лет при появлении симптомов острого назофарингита применяют комбинированный препарат лизоцим + пиридоксин для сокращения длительности и уменьшения тяжести последующего аденоидита.

Детям из групп риска по респираторным инфекциям рекомендованы лизаты бактерий (другие иммуностимуляторы) для сокращения длительности и уменьшения тяжести эпизодов аденоидита и его осложнений.

Как правило, проводится плановая профилактика курсами в соответствии с инструкцией 2–3 раза в год; применяются как пероральные, так и местные формы.

Для профилактики аденоидитов и их осложнений у детей может рассматриваться применение местных пробиотиков на основе бактерий нормальной микрофлоры глотки.

В информации для пациента указано, что следует обратиться к врачу, если после перенесённого простудного заболевания у ребёнка появились и в течение 2 недель сохраняются заложенность носа, храп, снижение слуха или кашель (при исключённой патологии нижних дыхательных путей).

5.2 Показания к госпитализации и выписке

Показанием к госпитализации является плановая аденотомия и (или) тонзиллотомия при наличии показаний и отсутствии противопоказаний. Лечение аденоидита амбулаторное или в консультативно-диагностическом отделении. После операции пациент выписывается при удовлетворительном общем состоянии и отсутствии осложнений.

5.3 Факторы, влияющие на исход лечения

При хронических соматических заболеваниях после аденотомии и (или) тонзиллотомии возможно их обострение в раннем послеоперационном периоде. Аллергический ринит повышает вероятность неполного регресса назальных симптомов (передней и задней ринореи, в меньшей степени заложенности носа). Ожирение повышает вероятность сохранения обструктивных нарушений сна после операции. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь повышает вероятность сохранения назальных симптомов и риск инфекционных осложнений в раннем послеоперационном периоде.

При гипертрофии нёбных миндалин медикаментозное лечение аденоидита крайне малоэффективно в отношении обструктивных нарушений сна.

При наличии у ребёнка сопутствующего заболевания, способного повлиять на результат операции, врач должен проинформировать об этом пациента или родителей до операции.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия нёбных миндалин»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 25.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года
Код в рубрикаторе	662_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Рекомендация о тонзиллэктомии взрослым с гипертрофией нёбных миндалин и СОАС дана без уровня убедительности рекомендаций и уровня достоверности доказательств, а в разделах о госпитализации, обезболивании и реабилитации упоминаются только аденотомия и тонзиллотомия.
- Для хронического аденоидита в разделе 1.4 предложены два кода: J31.1 («как возможный вариант кодирования») и J35.8 («например, аденоидит»).
- В комментарии к ибупрофену фраза о суппозиториях оборвана («ректальные суппозитории (у детей младше) 2 лет»), поэтому возрастная граница неоднозначна.